

CIRCUITO DO DOENTE CRÍTICO

I. INTRODUÇÃO

A criação do circuito do doente crítico (CDC) pretende dar resposta à necessidade de reconhecimento e abordagem precoces de doentes críticos admitidos no Serviço de Urgência, respeitando as orientações clínicas e formativas do colégio de especialidade de Medicina Intensiva e a Rede de Referência de Medicina Intensiva. Essa estratégia assenta numa parceria entre o Serviço de Medicina Intensiva do CHLO e o Serviço de Urgência (SU) do HSF/CHLO, através da implementação de equipas assistenciais no SU com a participação da Medicina Intensiva.

II. CARACTERIZAÇÃO

A actividade do CDC é assegurada por um médico sob coordenação do SMI, em presença física hospitalar e de apoio ao SU. Os médicos que desempenham esta função são médicos do SMI ou colaboradores externos, cuja experiência e capacidade de atuação na doença crítica é validada curricularmente (Suporte Avançado de Vida, formação na área do trauma, Sépsis e infeção grave, treino mínimo de 6 meses em Medicina intensiva) e pela Direção do SMI e pela Direção Clínica do CHLO.

A actividade clínica desempenhada pelo médico do CDC inclui o apoio à Sala de Reanimação e a consultoria de doentes do SU localizados no Serviço de Observação – SO.

Sala de Reanimação (SR)

A SR está integrada no SU do HSFx e tem como objetivo disponibilizar uma abordagem sistematizada e pluridisciplinar de situações clínicas ameaçadoras de vida ou função orgânica. São admitidos na SR doentes com as seguintes proveniências:

- Exterior não referenciado: através da Triagem de Manchester;
- Exterior referenciado: outros hospitais e INEM através de contacto prévio com médico da SR/Chefe de Equipa;
- Serviço de Urgência: através do contacto prévio com médico da SR;

Possui, como tal, um conjunto de características funcionais e logísticas específicas:

- a) Localiza-se à entrada do SU;
- b) Possui recursos humanos com treino e competência para a resposta à emergência, disponíveis em permanência e integrados nas equipas de urgência do SU;
- c) É ativada por um médico ou enfermeiro do SU sempre que se depre com uma situação que configure uma emergência médica/cirúrgica – situação clínica que, sem interferência, coloca a vítima em risco de vida ou d fice funcional grave em minutos;
- d) Tem espa o e recursos adequados   avalia  o e tratamento das m ltiplas situa  es de emergência admitidas no SU;
- e) Articula com peritos de v rias especialidades m dicas e cir rgicas;
- f) Tem recursos para exames laboratoriais e imagiol gicos em perman ncia;
- g) Elabora registos cl nicos das interven  es e desempenho;

- o encaminhamento dos doentes no SU, incluindo o acompanhamento para a realização de meios complementares de diagnóstico ou ao bloco operatório, sempre que tal for apropriado.

A intervenção do médico do CDC é feita mediante activação por um médico do SU – através da extensão telefónica 70705 – e deve realizar-se em estreita e mútua colaboração entre profissionais dos vários serviços (SMI, SU, Medicina Interna e Especialidades Médicas, Cirurgia Geral e outras Especialidades Cirúrgicas, Anestesiologia).

Nas situações em que há um contacto com as chefias de equipa/médicos do SU de uma entidade externa ao CHLO (INEM, outro hospital) a informar da chegada/transferência de um doente que cumpre algum dos critérios definidos na Tabela 1, o contacto com o médico do CDC deve ocorrer o mais precocemente possível, antes da chegada do doente ao HSF.

Nas situações de doentes admitidos por trauma, queimados e via aérea difícil deverá ser ativada, em simultâneo, a equipa de Anestesiologia de urgência (74320).

A decisão de dar procedência à ativação cabe ao médico do CDC, após avaliação do doente. Nas situações em que a ativação é considerada procedente, o médico do CDC assume a responsabilidade pelo doente, em coordenação com os médicos do SU e outras especialidades hospitalares. A responsabilidade nos cuidados ao doente cessa se o médico do CDC entender que o doente deixa de ter necessidade de cuidados de Medicina Intensiva ou se o doente for admitido no Serviço de destino. O médico do CDC é responsável pelo registo e partilha de informação clínica relevante, aquando da transmissão de responsabilidade clínica sobre o doente.

Na Tabela 1 estão enumerados os critérios orientadores propostos para ativação do médico do CDC para a SR.

Observação e encaminhamento de outros doentes do SU/SO

O médico do CDC deve estar disponível para a discussão clínica multidisciplinar de doentes internados no SO, mediante contacto pelo médico responsável.

Sugere-se a utilização dos seguintes critérios para observação e encaminhamento pelo médico do CDC:

1. Disfunções orgânicas agudas por critérios clínicos e/ou meios complementares de diagnóstico
 - Necessidade de estabelecimento de via aérea avançada
 - Insuficiência respiratória com necessidade de suporte ventilatório invasivo
 - SpO₂ < 85% com O₂ suplementar
 - Instabilidade hemodinâmica refratária
 - Disfunção microcirculatória com lactato persistentemente alto (>4 mmol/L) e/ou hipoperfusão periférica acentuada e refratária
 - Disfunção neurológica com GCS < 10 ou diminuição aguda na GCS > 2 pontos ou crises convulsivas de repetição ou prolongadas (>2 min de duração, sem recuperação do estado de consciência entre crises)
 - Disfunção renal grave com necessidade ou risco elevado de suporte invasivo

- Disfunção metabólica grave com necessidade ou risco elevado de suporte e/ou monitorização invasivos

Na Tabela 2 estão enumerados os critérios orientadores propostos para consultoria ao SMI.

É recomendável que, sempre que possível, o elemento do SMI escalado para o apoio ao SU/CDC estabeleça um contacto regular com a equipa assistencial do SU (contacto telefónico, contacto presencial no SU, participação nas visitas/passagens de doentes entre as equipas assistenciais do SU), de modo a conhecer o mais precocemente possível os doentes potencialmente críticos do SU.

Transporte de doentes

A exigência clínica dos doentes críticos, que, por disfunção de um ou mais órgãos ou sistemas, estão dependentes de meios avançados de monitorização e terapêutica, obriga a que o seu transporte cumpra todas as necessidades de diferenciação técnica inerentes à Medicina Intensiva. Como tal, o médico do CDC solicita e assegura o transporte intra e inter-hospitalar que cumprirem os critérios de doença crítica definidos na Tabela 3, de acordo com o exposto nos organigramas das Figura 1 e 2.

Admissão de doentes no SMI

Os doentes avaliados pelo médico do CDC e cujo destino seja qualquer uma das UCI's do SMI do CHLO deverá ser encaminhado para a UCI de destino o mais rapidamente possível, para optimização de cuidados diferenciados. Tal deve ser individualmente ponderado entre o médico do CDC e o médico do SMI.

PROPOSTA DE CRITÉRIOS DE ACTIVAÇÃO SMI NA SALA DE REANIMAÇÃO

A	COMPROMISSO DA VIA AÉREA / ESTRIDOR EDEMA FACE / LÍNGUA TRAUMA ALERGIA / HIPERSENSIBILIDADE / ANAFILAXIA QUEIMADURA DA FACE / LESÃO POR INALAÇÃO / ASPIRAÇÃO
B	PARAGEM RESPIRATÓRIA SpO₂ < 85% COM O₂ SUPLEMENTAR VENTILAÇÃO INEFICAZ / EXAUSTÃO VENTILATÓRIA DISPNEIA AGUDA GRAVE (PÓS TRAUMA, FR > 35, CIANOSE) VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA
C	PARAGEM CARDÍACA FREQ CARD < 40 OU > 140 + SINAIS DE GRAVIDADE* HIPOTENSÃO GRAVE E REFRATÁRIA HIPERLACTACIDÉMIA REFRATÁRIA (> 4 mmol/L) SUORTE VASOPRESSOR OU INOTRÓPICO / ESTIMULAÇÃO ELÉCTRICA HEMORRAGIA ACTIVA COM REPERCUSSÃO HEMODINÂMICA
D	GCS < 10 OU DIMINUIÇÃO AGUDA > 2 PONTOS CRISE CONVULSIVA REFRATÁRIA
VV	VIAS VERDES – SEMPRE QUE SE VERIFIQUE ALGUM DOS CRITÉRIOS OU DISFUNÇÕES ORGÂNICAS ANTERIORES VIA VERDE CORONÁRIA - GESTÃO MULTIDISCIPLINAR COM CARDIOLOGIA VIA VERDE AVC - GESTÃO MULTIDISCIPLINAR COM NEUROLOGIA VIA VERDE DE TRAUMA - GESTÃO MULTIDISCIPLINAR COM CIRURGIA GERAL, ANESTESIOLOGIA E OUTRAS ESPECIALIDADES CIRÚRGICAS VIA VERDE SÉPSIS
* DOR TORÁCICA, ALTERAÇÃO DO ESTADO DE CONSCIÊNCIA, SINAIS DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA OU HIPOTENSÃO	

Tabela 1 - Critérios de activação do SMI na Sala de Reanimação

PROPOSTA DE CRITÉRIOS PARA CONSULTORIA PELO SMI

DISFUNÇÕES ORGÂNICAS AGUDAS POR CRITÉRIOS CLÍNICOS E/OU MEIOS COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO	
A	NECESSIDADE DE ESTABELECIMENTO DE VIA AÉREA AVANÇADA
B	INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA COM NECESSIDADE DE SUPORTE VENTILATÓRIO INVASIVO OU NÃO INVASIVO SpO₂ < 85% COM O₂ SUPLEMENTAR VENTILAÇÃO INEFICAZ / EXAUSTÃO VENTILATÓRIA
C	HIPOTENSÃO GRAVE E REFRATÁRIA HIPERLACTACIDÉMIA REFRATÁRIA (> 4 MMOL/L) SUPORTE VASOPRESSOR OU INOTRÓPICO / ESTIMULAÇÃO ELÉCTRICA / NECESSIDADE DE CARDIOVERSÃO ELÉCTRICA HIPERTENSÃO GRAVE E REFRATÁRIA
D	GCS < 10 OU DIMINUIÇÃO AGUDA > 2 PONTOS CRISE CONVULSIVA PROLONGADA OU REPETIDA
R	DISFUNÇÃO RENAL GRAVE COM NECESSIDADE OU RISCO ELEVADO DE SUPORTE INVASIVO
M	DISFUNÇÃO METABÓLICA GRAVE COM NECESSIDADE OU RISCO ELEVADO DE SUPORTE E/OU MONITORIZAÇÃO INVASIVOS

Tabela 2 - Critérios para consultoria ao SMI

CRITÉRIOS PARA ACTIVAÇÃO DE TRANSPORTE DE NÍVEL C A REALIZAR PELA EEMI/CDC: ≥ 4 PONTOS OU QUALQUER ITEM COM 3 PONTOS.	
VIA AÉREA INVASIVA E SUPORTE VENTILATÓRIO	
Não	0
Traqueotomia	1
Ventilação não invasiva	2
Intubação traqueal/traqueotomia e ventilação invasiva	3
FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA (apenas contabilizável em doente sem suporte ventilatório)	
10 a 20/min	0
21 a 35/min	1
< 10/min OU > 35/min OU padrão irregular	2
OXIGENAÇÃO (apenas contabilizável em doente sem suporte ventilatório)	
Pa/FiO ₂ > 300	0
200 < Pa/FiO ₂ < 300	1
100 < Pa/FiO ₂ < 200	2
Pa/FiO ₂ < 100	3
SUPORTE HEMODINÂMICO	
Não	0
Antihipertensores OU antiarrítmicos/cronotrópicos em perfusão contínua ev	1
Dopamina 5 a 15 mcg/kg/min	2
Dopamina >15 mcg/kg/min OU inotrópicos/vasopressores em perfusão contínua ev	3
Arritmia com instabilidade clínica	3
ESTADO NEUROLÓGICO	
GCS 15	0
13 ≤ GCS ≤ 14	1
12 ≤ GCS ≤ 10	2
GCS ≤ 9	3

Tabela 3 - Critérios para transporte de doentes críticos no CHLO pelo SMI.
Adaptado de Etzebarria et al. Eur J Emerg Med, 1998

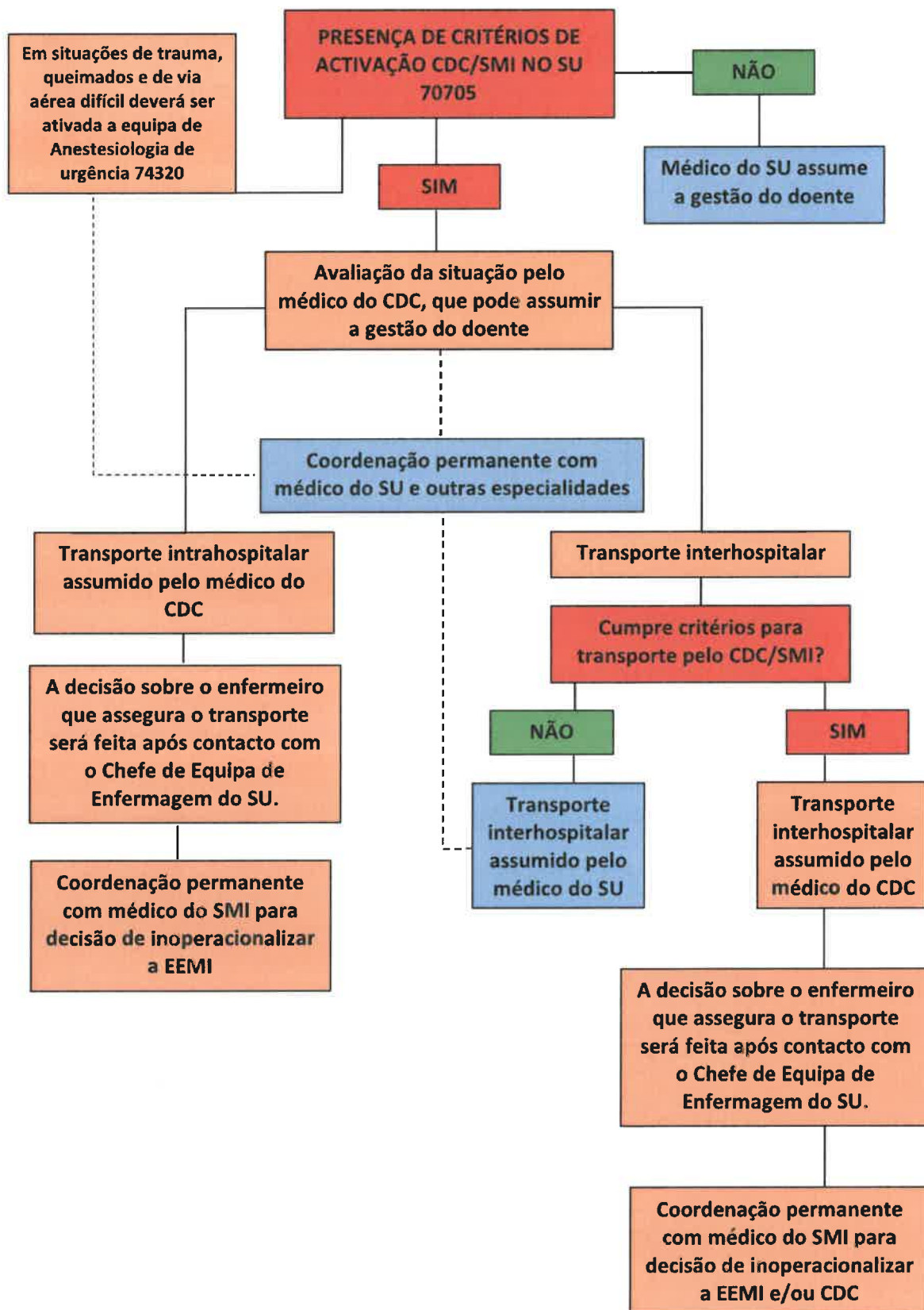


Figura 1 - Fluxograma da ativação/atividade clínica a desenvolver pelo médico do CDC.

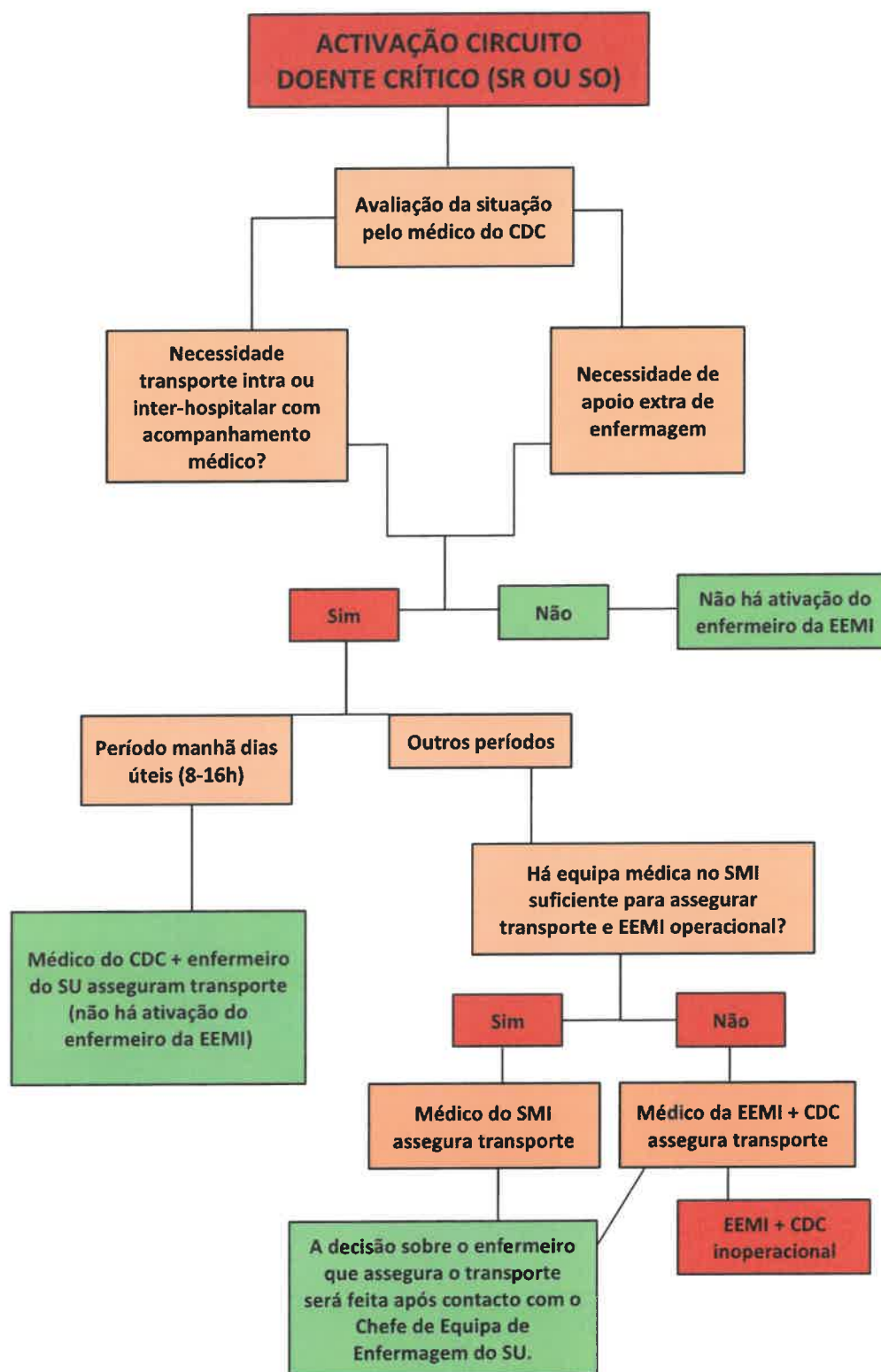


Figura 2 - Fluxograma de decisão para transporte de doentes do CDC

O Diretor do Serviço de Medicina Intensiva

O Coordenador da Equipa de Emergência
Médica Intrahospitalar

Assinado por : **António José Pereira Pais Martins**

Num. de Identificação: BI04475691

Data: 2023.03.09 14:56:30 Hora padrão de GMT



CHAVE MÓVELins
.....



Dr. David Nora